TOME 16 • RÉFÉRENTIEL CONCOURS R2C

Nutrition & Activité Physique

Collège des Enseignants de Nutrition & Diététique • 116 pages

Extrait de prévisualisation officielle du Tome 16 : Nutrition & Activité Physique.

Cet extrait contient une sélection représentative de fiches de synthèse, de tableaux diagnostiques et de repères méthodologiques indispensables pour la préparation des Épreuves Dématérialisées Nationales (EDN) et des Épreuves Cliniques d'Objectif Structuré (ECOS).

- **Volume complet :** 116 pages A4 grand format.
- **Éditeur & Collège :** Collège des Enseignants de Nutrition & Diététique.
- **Classification pédagogique :** Rangs A (Socle obligatoire pour tous) et Rangs B (Différenciation de spécialité).
- **Supports didactiques :** Tableaux décisionnels, arbres diagnostiques, posologies de première intention et pièges zéros.

Spécification	Détail Officiel
Format	PDF vectoriel haute résolution optimisé grand écran et tablette
Pagination totale	116 pages complètes non tronquées
Mises à jour	Conforme dernières conférences de consensus HAS & R2C 2026
Épreuves ciblées	EDN (QCMs, KFP, TCS) et ECOS (Stations pratiques 7 min)

PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL • TOME 16

Collège des Enseignants de Nutrition & Diététique • Réforme R2C 2026

Le programme officiel du 2e Cycle des études médicales structure les connaissances cliniques selon une hiérarchisation stricte en **deux niveaux de maîtrise** :

• **Rang A (Indispensable pour tout futur médecin) :** Représente le socle des connaissances incontournables. Tout interne, quelle que soit sa spécialité future, doit maîtriser ces items à la perfection (définitions, urgences vitales, signes cardinaux, thérapeutiques de première ligne et conduites à tenir d'extrême urgence). Une impasse sur un Rang A est sanctionnée par des points de pénalité majeurs lors des EDN.

• **Rang B (Connaissances approfondies de spécialité) :** Constitue le niveau discriminant pour les classements d'accès aux postes d'internat les plus sélectifs. Il aborde les subtilités physiopathologiques, les protocoles de deuxième et troisième lignes, les posologies hospitalières complexes et les examens paracliniques spécialisés.

Méthodologie pédagogique adoptée dans ce volume :
1. **Fiches synthétiques standardisées :** Chaque chapitre débute par le rappel des objectifs terminaux du Collège.
2. **Mise en valeur visuelle :** Balises Rang A (en surbrillance verte) et Rang B (en surbrillance bleue).
3. **Points de vigilance & Pièges de concours :** Encarts dédiés aux confusions fréquentes retrouvées dans les annales officielles.
4. **Tableaux comparatifs synthétiques :** Condensé de données permettant une révision rapide en quelques minutes.

RAPPEL IMPORTANT POUR L'ÉPREUVE EDN :
Les Questions Isolées (QI), Dossiers Progressifs (DP) et Tests de Concordance de Script (TCS) reposent à 100% sur les données publiées par le Collège officiel. Les traités anciens ou les sources non harmonisées comportent souvent des discordances susceptibles d'entraîner des pertes de points sévères.

SOMMAIRE DU RÉFÉRENTIEL COMPLET

Tome 16 • Nutrition & Activité Physique (116 pages)

SOMMAIRE DÉTAILLÉ DU MODULE

- Chapitre 01 : Dyslipidémie (223)
- Chapitre 02 : Obésité (253)
- Chapitre 03 : Dénutrition (250)
- Chapitre 04 : Amaigrissement (251)
- Chapitre 05 : Modifications thérapeutiques du mode de vie (248, 249)
- Chapitre 06 : Aptitude au sport, Besoins nutritionnels chez le sportif (256)
- Chapitre 01 — Dyslipidémie (223)
- Introduction
- Rappels : Lipoprotéines
- Précisions sur la relation Dyslipidémie/Athérosclérose
- Bilan lipidique
- Dyslipidémies secondaires (tombé en annale)
- Cas particulier de l'hyperlipidémie associée au DT2, et au syndrome métabolique, ne régresse pas avec normalisation glycémique (hyperlipidémie est fréquemment associée à l'état d'insulinorésistance noté dans le syndrome métabolique et le DT2)
Antipsychotiques
- Hyperlipoprotéinémie primaire
- Classifications
- Il existe 3 grands phénotypes :
- Classification de Fredrickson
- Hypercholestérolémie pure
- Hypercholestérolémie pure familiale monogénique (type 2a)
- Hypercholestérolémie polygénique (type 2a)
- Hypertriglycéridémie pure
- Hypertriglycéridémie familiale ou multifactorielle (type IV) = forme modérée
- Hyperchylomicronémies primitives (type 1 et 5) = forme sévère
- Formes avec hyperchylomicrone■mie exclusive (type 1) sont exceptionnelles
- Hyperlipidémies mixtes
- Hyperlipidémies combinées familiales
- Trait commun des hyperlipide■mies combine■es

EXTRAIT DIDACTIQUE DU COURS

Concepts Clés & Sémiologie Didactique • Rangs A et B

Chapitre 01 : Dyslipidémie (223)
Chapitre 02 : Obésité (253)
Chapitre 03 : Dénutrition (250)
Chapitre 04 : Amaigrissement (251)
Chapitre 05 : Modifications thérapeutiques du mode de vie (248, 249)
Chapitre 06 : Aptitude au sport, Besoins nutritionnels chez le sportif (256)

Chapitre 01 — Dyslipidémie (223)

Introduction

Rappels : Lipoprotéines
Précisions sur la relation Dyslipidémie/Athérosclérose
Bilan lipidique
Dyslipidémies secondaires (tombé en annale)
Cas particulier de l'hyperlipidémie associée au DT2, et au syndrome métabolique, ne régresse pas avec normalisation glycémique (hyperlipidémie est fréquemment associée à l'état d'insulinorésistance noté dans le syndrome métabolique et le DT2)
Antipsychotiques

Hyperlipoprotéinémie primaire

Classifications
Il existe 3 grands phénotypes :

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • I

Synthèse Diagnostique & Critères de Classification • Nutrition & Activité Physique

Caractéristique	Description / Données Cliniques
Rôle	Particules en charge du transport des lipides dans le plasma
Chylomicrons	Synthétisés dans la cellule intestinale, transportent les lipides d'origine alimentaire
VLDL IDL	1. Very low density lipoproteins : synthétisées par le foie, transporte les lipides d'origine endogène (produits par le corps) 2. Intermediate Density Lipoproteins : résulte de l'hydrolyse des VLDL
LDL	1. Low density lipoproteins résulte de l'hydrolyse des IDL 2. Transporte le cholestérol dans le foie ou du foie vers les cellules périphériques, en se fixant sur un récepteur spécifique (LDL-récepteur qui est sous le contrôle de la PCSK9 qui diminue le nombre de LDL-R à la surface de l'hépatocyte)
HDL	High Density Lipoproteins sont produites par le foie, qui jouent un rôle essentiel dans la captation du cholestérol dans les tissus périphériques pour le rapporter au foie en vue de sa dégradation (voie de retour du cholestérol)

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • II

Arbres de Décision & Algorithmes Cliniques • Nutrition & Activité Physique

Caractéristique	Description / Données Cliniques
Anomalies athérogènes	Morbidité-Mortalité cardio-vasculaire est associée à : - Augmentation du LDL-cholesterol (LDLc = mauvais cholestérol, athérogène) - Augmentation des triglycérides (TG, rarement isolée) : FR moins puissant que augmentation des LDLc - Diminution du HDL-cholesterol (HDLc = bon cholestérol, protège du risque d'athérome) : -> Diminution < 0,4 g/L chez l'homme, < 0,5 g/L chez la femme -> Marqueur de risque indépendant puissant (en revanche des données récentes suggèrent le contraire) -> Fonctionnalité des HDL, qui peut être altérée dans certaines situations cliniques (ex. diabète) -> Dosage du HDLc demeure utile en prédiction CV , mais il n'est pas une cible thérapeutique [X]
Topographie	Principale atteinte = Maladie coronaire (RR x3 corrélé à l'élévation du LDLc)
Physiopath.	1. Dépôt des lipoprotéines athérogènes (principalement les LDL) 2. Oxydation des LDL dans la paroi artérielle, favorisée par : temps de séjour allongé + environnement inflammatoire local 3. LDL oxydés ne sont alors plus reconnues par le récepteur LDL-R 4. Recrutement de macrophages au niveau de la plaque naissante pour internaliser LDL oxydées (via récepteurs de type SR-A = récepteurs scavengers/éboueurs) 5. Transformation macrophages en cellules spumeuses (chargées de gouttelettes cytoplasmiques d'esters de cholestérol) 6. Diminution des capacités vasodilatatrices et antithrombotiques de l'endothélium : favorisée par tabac et LDL oxydés 7. Réaction inflammatoire auto-entretenue sécrétant des métalloprotéases destructrices de la matrice extracellulaire 8. Migration des cellules musculaires lisses de la média vers la néo-intima 9. Sécrétion des facteurs de croissance, de collagène et de la matrice extracellulaire, menant à l'organisation dans l'intima de : -> Centre lipidique : nécrotique, renferme stries lipidiques + cellules musculaires lisses + cellules inflammatoires (stries lipidiques sont retrouvées dès le jeune âge lors des autotopsies) -> Chape fibreuse : apparition tardive, agit comme couverture du centre lipidique, composé de collagène de type 1
Histologie	Cellules spumeuses = marqueur histologique des plaques d'athérome

POINTS CLÉS & PIÈGES DE CONCOURS R2C

Les Erreurs Fréquentes & Mots-Clés Zéros • Tome 16

1. Confusion Rang A vs Rang B : Aux EDN, les questions de Rang A représentent au minimum 60% du total des points. Tenter de retenir des posologies d'exception avant d'avoir sécurisé le réflexe diagnostique de première ligne est la première cause de contre-performance.

2. Les Pièges Éliminatoires 'Zéro à la question' :
• Oubli systématique de vérifier les contre-indications absolues avant une prescription.
• Confusion entre urgence médicale (prise en charge immédiate au déchocage) et prise en charge différée en consultation.
• Prescription d'examens invasifs ou irradiants injustifiés sans avoir réalisé l'examen physique initial complet.

3. Méthodologie du Dossier Progressif :
Ne préjugez jamais de la réponse de la question suivante pour orienter votre choix présent. Chaque palier d'un dossier progressif s'évalue selon les seules données cliniques disponibles à cet instant précis.

■ CONSEIL DU MAJOR POUR CE TOME :
Faites une première lecture complète des tableaux de synthèse pour créer une cartographie mentale des items. Passez ensuite aux QCMs d'entraînement pour tester votre rappel actif sur les seuils chiffrés et les arbres décisionnels.

RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES & VOLUME INTÉGRAL

Tome 16 • Nutrition & Activité Physique (116 pages)

Sociétés Savantes & Collèges Référents :
• Collège des Enseignants de Nutrition & Diététique
• Recommandations de Bonne Pratique de la Haute Autorité de Santé (HAS)
• Conférences de consensus et publications des Sociétés Médicales Nationales et Européennes

Accéder au Référentiel Intégral :
Ce tome complet (116 pages) comprend l'intégralité des chapitres au programme du 2e Cycle, avec toutes les fiches de cours, l'ensemble des arbres diagnostiques en haute résolution et les grilles d'évaluation complètes.

• **Disponible à l'unité :** 9,99 € au format numérique haute performance.
• **Pack Intégral 28 Tomes (Économie de 85%) :** Comprend les 28 Référentiels Collèges (8 750 pages), la Banque des 100 QCMs Corrigés, le Carnet d'Erreurs du Major EDN 2025 et le Guide Officiel des 15 Stations ECOS 2026.

Édition conforme au référentiel R2C 2026. Tous droits réservés.